antibiotiques et une hémolyse intravasculaire. Devant l'absence du séjour du patient et de son donneur de moelle dans une zone d'endémie et devant la négativité de la goutte épaisse et de la PCR chez le donneur de CSH, l'origine transfusionnelle a été suspectée.

Matériel et méthodes L'enquête a été déclenchée par le CNTS après déclaration du cas par le CNGMO. La vérification des données figurant sur les fichiers informatiques des donneurs de sang, à la recherche d'un ou de plusieurs donneurs ayant séjourné dans des zones d'endémie, a révélé un seul donneur originaire de la côte d'Ivoire. Celui-ci a été convoqué pour réaliser un frottis sanguin, une goutte épaisse, une sérologie parasitaire et une PCR.

Résultats L'interrogatoire a révélé que ce donneur a présenté dans ces antécédents un accès palustre. La goutte épaisse ainsi que le frottis sanguin n'ont pas révélé le parasite. La sérologie parasitaire du paludisme est positive au 1/20e. La PCR à plasmodium falciparum est positive.

Conclusion Ce cas illustre l'importance du diagnostic du paludisme chez le patient malgré l'absence de facteurs de risque chez le receveur et le donneur de CSH. Une remise en cause de la stratégie de la sélection des donneurs de sang et de dépistage du paludisme a été soulevée par les professionnels de la santé.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2017.06.233

P111

Séroprévalence virale et allo-immunisation post-transfusionnelle chez les patients suivis pour syndrome drépanocytaire majeur

Alioune Badara Senghor*, Moussa Seck, Blaise Felix Faye, Macoura Gadji, Youssou Bamar Gueye, Rose Seck, Diarriatou Sy, Nata Dieng, Sokhna Aicha Touré, Tandakh Ndiaye Dieye, Saliou Diop
Centre national de transfusion sanguine, Dakar, Sénégal
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : absenghor2hs@yahoo.fr (A.B. Senghor)

Introduction Il existe un risque transfusionnel de transmission du VIH, des hépatites B et C et d'allo-immunisation anti-érythrocytaire pour toute population transfusée comme les drépanocytaires. Notre étude avait pour objectif de déterminer la séroprévalence du VIH, VHB et VHC, d'évaluer l'allo-immunisation anti-érythrocytaire chez les sujets drépanocytaires majeurs suivis au service d'hématologie clinique du CNTS.

Matériels et méthodes Cette étude prospective a été menée sur une période de 6 mois. Chaque patient a bénéficié du dépistage de l'Ag-HBs, l'Ac Anti-VHC, Ac/Ag VIH et de la recherche des agglutinines irrégulières (RAI).

Résultats Notre population d'étude est composée de 250 patients drépanocytaires majeurs dont 107 soit 42,8 % étaient de sexe masculin et 143 soit 57,2 % de sexe féminin. Les patients étaient âgés de 2 à 59 ans avec un âge moyen de 24,84 ± 9 ans. Parmi ces sujets drépanocytaires 150 ayant reçu au moins une transfusion avaient bénéficié de la RAI. Les séroprévalences étaient de 2,4 % pour le VHB et de 1,2 % pour le VHC. Tous les patients étaient négatifs pour le VIH. La fréquence de l'immunisation était estimée à 22,66 % avec une prédominance des anti-Kell et anti-Rhésus respectivement de 23,67 % et 34,19 %. Le nombre d'unités de sang transfusé est significativement associé à la positivité de la RAI ($p = 0{,}03$).

Conclusion La prévalence VIH, VHB et VHC chez les drépanocytaires transfusés était quasi similaire à celle retrouvée chez les drépanocytaires non transfusés. Par contre, la fréquence de l'immunisation anti-érythrocytaire était élevée dans notre étude.

Mots clés Transfusion ; Drépanocytose ; Allo-immunisation ; Prévalence virale ; Dakar

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2017.06.234

P112

Évaluation du risque d'infections transmissibles par transfusion sanguine à Libreville

Mireille Jophrette Ntsame Ndong[1,*], Jean Marie Eko Mba[2], Cyrille Bisseye[2]
[1] *Centre National de transfusion sanguine de Libreville, Libreville, Gabon*
[2] *Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire, université des sciences et techniques, Masuku, Franceville, Gabon*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : dcntslbv@yahoo.com (M.J. Ntsame Ndong)

Le dosage systématique des antigènes et des anticorps viraux, bactériens chez les donneurs de sang, associé à la sélection des donneurs de sang à faible risque de transmission d'agents pathogènes, a contribué à l'amélioration de la sécurité transfusionnelle dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Cette étude rétrospective trisannuelle avait pour but, d'évaluer la séroprévalence des virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus de l'hépatite C (VHC) et du Treponema pallidum chez les donneurs de sang de premier don de Libreville, et d'identifier les profils sociodémographiques des donneurs à risque.

Le diagnostic des agents infectieux a été réalisé par des tests immuno-enzymatiques de quatrième génération.

Au total, 27 210 donneurs de sang de premier don ont été enregistrés, soit 16,6 % de femmes et 83,4 % d'hommes. Les donneurs qui avaient moins de 35 ans étaient de 78,4 %. Les donneurs volontaires représentaient 32,1 %. La séroréactivité globale du VIH, VHC et de la syphilis était respectivement de 3,4 %; 1,2 % et 3,2 %. Les donneurs de sexe féminin et ceux plus âgés de 35 ans étaient significativement plus réactifs au VIH et à la syphilis. Les séroréactivités du VHC et de la syphilis ont significativement baissé entre 2009 et 2015. Les donneurs familiaux étaient significativement plus réactifs que les bénévoles.

Le risque de contamination bactérienne ou virale est réel chez les donneurs de sang malgré les séroprévalences des marqueurs infectieux en diminution. Le donneur majoritaire au CNTS est familial, le profil type du donneur à risque. Le donneur de choix à faible risque, est bénévole, de sexe masculin âgé de moins de 35 ans, le type de donneur à motiver et à fidéliser.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2017.06.235

P113

Étude de la co-infection avec l'hépatite virale C, le SIDA et la syphilis chez des sujets porteurs de l'antigène HBs. Étude rétrospective à propos de 3172 cas

Asma Kedous*, Maroua Said, Afifa Doghri, Ghassen Kharroubi, Neila Ajam, Nasreddine Grilitli
Centre militaire de transfusion sanguine, Le Bardo, Tunisie
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : asmakedous@yahoo.fr (A. Kedous)

Introduction L'infection au virus de l'hépatite virale B (HBV), de l'hépatite C (HCV), au virus de l'immunodéficience (VIH) et au germe Treponema pallidum partagent des modes de transmission. Une co-infection entre ces pathogènes a été décrite dans la littérature. On s'est intéressé à rechercher la fréquence, chez des sujets porteurs de l'antigène HBs, des co-infections avec les virus de l'HCV et l'HIV et l'agent de la syphilis afin de mettre le point sur une éventuelle association.

Méthodes C'est une étude rétrospective menée au CMTS de 2006 à 2015. Le dépistage de l'HBV a été réalisé par Elisa (enzyme-linked immunosorbent assay) 4e génération. La confirmation était faite par test de neutralisation. Le dépistage des anticorps anti-VHC était réalisé par Elisa de quatrième génération. La confirmation était faite par Immunoblot. Le dépistage de l'HIV était fait par Elisa. La confirmation était faite par Western-Blot. La recherche de la syphilis a été faite par le test d'hémagglutination. Résultats On a recensé 3172 sujets porteurs de l'Ag-HBs. Parmi eux, six cas étaient infectés simultanément par l'HVC, sans relation statistiquement significative. Ils sont tous de sexe masculin. En 2006, on a noté deux cas. En 2008, deux autres cas. En 2010 et 2011, un cas par année. Aucun cas de co-infection HVB/HIV ni HVB/syphilis n'a été trouvé.